

المساندة الاجتماعية وعلاقتها بصورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن
دراسة ميدانية بقطاع غزة

Social Support and Its Relationship to Body Image for Patients with
Chronic Kidney Failure: A Field Study in the Gaza Strip

محمد عمر أبوزهري

باحث دكتوراة، تخصص صحة نفسية، جامعة القرآن الكريم وتأسيس العلوم، السودان

DOI:

تاريخ النشر: 2026 /01 /01

تاريخ القبول: 2025 /05 /14

تاريخ الاستلام: 2025 /01 /30

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين المساندة الاجتماعية وصورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن، باستعمال المنهج الوصفي التحليلي على عينة مكونة من 205 مرضى. وأظهرت النتائج أن مستوى المساندة الاجتماعية لديهم كان عالياً، في حين جاء مستوى صورة الجسم بدرجة متوسطة. كما كشفت الدراسة عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المساندة الاجتماعية وصورة الجسم، مما يشير إلى تأثير الدعم الاجتماعي في تحسين نظرة المرضى لأجسادهم. ولم تُظهر النتائج فروقاً دالة إحصائية في مستويات المساندة الاجتماعية أو صورة الجسم تبعاً للجنس أو مدة الإصابة، مع وجود فروق مرتبطة بالمؤهل العلمي في المساندة الاجتماعية فقط. وأوصت الدراسة بتعزيز دور الأسرة والأصدقاء، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين، وتصميم برامج إرشادية وعلاجية لمرضى الفشل الكلوي.

الكلمات المفتاحية: المساندة الاجتماعية، صورة الجسم، الفشل الكلوي المزمن.

Abstract:

The study aimed to examine the relationship between social support and body image among patients with chronic kidney failure, using a descriptive-analytical approach on a sample of 205 patients. The results indicated that the level of social support was high, while the level of body image was moderate. A statistically significant relationship was found between social support and body image, suggesting that increased social support may improve patients' perception of their bodies. No statistically significant differences were found in levels of social support or body image based on gender or duration of illness, while differences

in social support were observed according to educational level. The study recommended enhancing the role of family and friends, activating the role of social workers in hospitals and health centers, and designing counseling and therapeutic programs for patients with kidney failure.

Keywords: *Social support, body image, chronic renal failure.*

مقدمة

الصحة من أعظم نعم الله على الإنسان، وهي تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، كما قال النبي ﷺ: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ" (البخاري، كتاب الرقاق، 8/185، رقم: 6412). ولا تقتصر الصحة على غياب المرض، بل تشمل التوازن الجسدي والنفسي والعقلي والاجتماعي. ومن أبرز التحديات الصحية التي تهدد هذا التوازن مرض الفشل الكلوي المزمن، الناتج غالبًا عن أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري (Abboud & Henrich, 2010, p.20)، والذي يسبب تغيرات جسدية مثل تورم الوجه وتغير لون الجلد، تؤثر سلبيًا على الحالة النفسية وصورة الجسم (Kimmel & Peterson, 2005).

في هذا الإطار، تُعد المساندة الاجتماعية عنصرًا حاسمًا في دعم مرضى الفشل الكلوي، إذ تساعدهم على التكيف والتقليل من الضغوط النفسية. وقد أشار الربيعية (1997، ص. 42) إلى أن الدعم الاجتماعي يعزز الثقة بالنفس ويقلل من المعاناة النفسية.

فيما عرّف أبو مرزوق (2018، ص. 35) المساندة الاجتماعية بأنها "كل أشكال الدعم الذي يتلقاه الفرد من البيئة المحيطة لمواجهة المواقف الصعبة". كما أثبتت دراسة رشوان (2009، ص. 64) أن هذا النوع من الدعم يُحسن من صورة الجسم والتوافق الاجتماعي لدى المرضى.

أما صورة الجسم، فهي تمثل مشاعر الفرد وتقييمه لمظهره الخارجي (الشريفين والوهبي، 2018، ص. 18)، وتُعد من المؤثرات الأساسية في التوازن النفسي والاجتماعي، خاصة عند المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة (الشبراوي، 2001، ص. 24)، وانطلاقًا من خبرة الباحث في قسم الكلى بمجمع ناصر الطبي، لاحظ وجود تغيرات في صورة الجسم والجانب الانفعالي لدى المرضى، مما دفعه لدراسة العلاقة بين المساندة الاجتماعية وصورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن.

مشكلة الدراسة

حددت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: ماهي طبيعة العلاقة بين المساندة الاجتماعية وصورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن في قطاع غزة؟ ويتفرع عنه التساؤلات الفرعية التالية:

1. ما درجة المساندة الاجتماعية لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن؟
2. ما درجة صورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن؟
3. هل توجد علاقة بين المساندة الاجتماعية وصورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن؟

4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى المساعدة الاجتماعية تعزى للمتغيرات (النوع، المؤهل العلمي، مدة الإصابة)؟
5. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى صورة الجسم تعزى للمتغيرات (النوع، المؤهل العلمي، مدة الإصابة)؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة المساعدة الاجتماعية وصورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن، إضافة إلى دراسة العلاقة بين المساعدة الاجتماعية وصورة الجسم لديهم. كما تسعى إلى تحديد الفروق ذات الدلالة الإحصائية في مستويات المساعدة الاجتماعية وصورة الجسم بناءً على متغيرات مثل النوع، المؤهل العلمي، ومدة الإصابة.

أهمية الدراسة: تكتسب الدراسة أهميتها من كونها دراسة جديدة تسلط الضوء على مرضى الفشل الكلوي المزمن، الذين لم تحظَ حالتهم بالكثير من البحث العلمي سابقاً. تقدم الدراسة تصوراً واضحاً حول المساعدة الاجتماعية، صورة الجسم لدى هذه الفئة، مما يفيد العاملين في المجال النفسي لفهم الحالة النفسية للمرضى وتحسين طرق التعامل معهم. كما تزود الدراسة أسر المرضى بمعلومات مهمة حول أهمية دعم المساعدة الاجتماعية إلى جانب العلاج الدوائي، مما يساهم في مواجهة المرض والتعايش معه بشكل أفضل.

فروض الدراسة:

1. توجد علاقة بين المساعدة الاجتماعية وصورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن.
2. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى المساعدة الاجتماعية تعزى للمتغيرات (النوع، المؤهل العلمي، مدة الإصابة).
3. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى صورة الجسم تعزى للمتغيرات (النوع، المؤهل العلمي، مدة الإصابة).

حدود الدراسة:

1. الحد الموضوعي: اقتصر هذه الدراسة على بحث المساعدة الاجتماعية وعلاقتها بصورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن.
2. الحد البشري: طبقت هذه الدراسة على مرضى الفشل الكلوي المزمن.
3. الحد المكاني: اقتصر تطبيق أدوات الدراسة على المرضى المترددين على قسم الغسيل الكلوي بمجمع ناصر الطبي بمحافظة خان يونس، ومستشفى أبو يوسف النجار بمحافظة رفح.
4. الحد الزمني: طبقت هذه الدراسة في العام الدراسي 2023 - 2024 م من شهر فبراير إلى شهر يونيو.

مصطلحات الدراسة:

المساندة الاجتماعية: "تفاعل اجتماعي يُعبّر عن الاهتمام والمساعدة والرضا عنها، مما يمنح الفرد الحماية ويعزز ثقته بنفسه، ويشترط وجود أشخاص مقربين يدعمونه عند الحاجة. أما التعريف الإجرائي، فهو الدرجة التي يحققها الفرد في مقياس المساندة الاجتماعية المستخدم في الدراسة" (زعر، 2018، ص. 52).

صورة الجسم: "موقف الفرد واتجاهه نحو شكل وحجم وجمال جسمه، وهي صورة ذهنية تتضمن تقييماً وخبرات انفعالية مرتبطة بصفاته الجسمية. أما التعريف الإجرائي، فهو الدرجة التي يحققها الفرد في مقياس صورة الجسم المستخدم في الدراسة" (الشاعر، 2014، ص. 61).

الفشل الكلوي المزمن: "تدهور تدريجي وغير قابل للعكس في وظائف الكلى، يؤدي إلى عجز الجسم عن التخلص من مخلفات الأيض والحفاظ على توازن السوائل والأحماض والمواد الكيميائية، مما يرفع مستويات اليوريا والنيروجين والكرياتينين في الدم" (Smeltzer & Bare, 2000, p. 67).

الدراسات السابقة:

أولاً: دراسات تتعلق بالمساندة الاجتماعية:

1. دراسة علي (2020): هدفت لتحديد مستوى المساندة الاجتماعية ومعنى الحياة لدى مرضى الأمراض المزمنة، وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية، على عينة من 270 مريضاً. لم توجد فروق بين أبعاد المساندة الاجتماعية، ووجدت علاقة إيجابية دالة بين المساندة الاجتماعية ومعنى الحياة، مع فروق بين الجنسين في بعض أبعاد الدعم.

2. دراسة السعدي (2019): بحثت العلاقة بين الدعم الاجتماعي ونوعية الحياة لدى 123 مريض فشل كلوي. لم تُظهر فروقاً حسب الجنس أو مدة المرض، وأكدت وجود علاقة إيجابية بين الدعم الاجتماعي المدرك وجودة الحياة.

3. دراسة يسينس وآخرون Yucens (2019): فحصت العلاقة بين الأمل والقلق والاكتئاب واستراتيجيات المواجهة والمساندة الاجتماعية لدى مرضى الكلى المزمن، مع عينة من 65 مريضاً. أكدت وجود علاقة إيجابية بين المساندة الاجتماعية ومستوى الأمل.

352

4. دراسة زينجين وآخرون Zengin, et al (2018): درست العلاقة بين استراتيجيات المواجهة والمساندة الاجتماعية لأولياء أمور أطفال مصابين بأمراض كلوية، ووجدت علاقة إيجابية بين الدعم واستراتيجيات المواجهة، كما بينت أن نقص الدعم قد يؤدي إلى تأنيب الذات.

5. دراسة هيتراشي Hettiarachchi (2018): وصفت العوامل المرتبطة بالضغط النفسي لدى 382 مريض كلى مزمن، ووجدت علاقة عكسية بين المساندة الاجتماعية والضغط النفسي، وكذلك بين استخدام استراتيجيات المواجهة والضغط.

ثانياً: دراسات تتعلق بصورة الجسم:

1. دراسة بيسر وديمير (2020) Biçer, S, & Demir: هدفت لتقييم إدراك صورة الجسم والرضا عن الحياة لدى 135 مريض غسيل كلوي. أظهرت النتائج تدني صورة الجسم خاصةً لمن هم فوق 65 سنة، عاطلين عن العمل، محدودي الدخل، وخضعوا للغسيل لفترة طويلة، وتأثرهم السلبي بصورة الجسم والرضا عن الحياة.
 2. دراسة بخيت (2020): درست العلاقة بين صورة الجسم ونوعية الحياة والقلق لدى 75 مريضة سرطان الثدي. وجدت علاقة سلبية بين صورة الجسم ونوعية الحياة، وأن صورة الجسم تنبئ بنوعية الحياة والقلق، دون اختلاف حسب العمر.
 3. دراسة الرشيد (2019): بحثت العلاقة بين اضطراب صورة الجسم والاكتئاب لدى 96 مريض سكري. أظهرت علاقة ارتباطية دالة بين اضطراب صورة الجسم والاكتئاب، وكون الإناث أكثر اضطراباً، مع فروق تعزى للعمر.
 4. دراسة إسماعيل (2017): بحثت العلاقة بين سمات الشخصية وصورة الجسم لدى 300 بدين. وجدت علاقة عكسية بين العصابية وصورة الجسم، وعلاقة طردية بين الانبساط وصورة الجسم، مع فروق حسب المؤهل العلمي دون اختلافات جنسية.
 5. دراسة موسى والبغدادي (2016): درست تأثير الإعاقة الصحية بمرض السكري على تشوه صورة الجسم بين 163 طالباً (مرضى وأصحاء). لم تُظهر فروقاً بين المجموعتين في اضطراب تشوه صورة الجسم.
- من خلال إطلاع الباحث على الدراسات السابقة وجد أن دراسته الحالية اتفقت مع الدراسات السابقة في بعض الجوانب من ناحية، واختلفت معها في بعض الجوانب من ناحية أخرى. كونها لم تستخدم نفس العينة والمتغيرات مجتمعة، ويظهر الاختلاف واضحاً في الأهداف المرجوة من كل دراسة ومتغيراتها، ونوع وحجم الدراسة والبيئة التي طبقت فيها تلك الدراسات. كذلك تختلف هذه الدراسة عن الدراسات الأخرى أنها دراسة نوعية ألقت الضوء على شريحة لم تنل نصيبها الكافي من الدراسات، كما تناولت المحاور مثل المساندة الاجتماعية وصورة الجسم، فلم يجد الباحث أي دراسة مشابهة لدراسته مجتمعة فيها المتغيرات معا وخاصة مرضى الفشل الكلوي المزمن _ حسب علم الباحث _.

الإطار النظري:

المبحث الأول: المساندة الاجتماعية

مفهوم المساندة الاجتماعية:

تُعد المساندة الاجتماعية دعماً مادياً أو معنوياً يُقدّم للمريض لرفع روحه المعنوية ومساعدته على التكيف مع المرض (عامر، 2010، ص. 63).

ويعرفها الدامر (2014، ص. 85) بأنها "دعم انفعالي ومادي يتلقاه الفرد من محيطه، ويعتمد على مدى إدراكه له".

أما محمد (2015، ص. 25) فيراها "استجابة من البيئة المحيطة لتخفيف الضغوط وتمكين الفرد من التكيف".

ووفقاً لكابلان، فهي "شبكة من العلاقات طويلة الأمد التي تُوفر الدعم العاطفي عند الحاجة" (إبراهيم، 2017، ص. 36).

و يخلص الباحث إلى أن المساندة الاجتماعية لمرضى الفشل الكلوي تمثل شبكة من المساعدات التي تمنحهم الطمأنينة وتساعدهم على مواجهة المرض والتكيف مع حالتهم.

المساندة الاجتماعية في الاسلام:

الإسلام هو دين الرحمة والتكافل، ويحث على المساندة الاجتماعية من خلال عدة مظاهر. من أبرزها الإخاء، كما ورد في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10]، وهي رابطة تقوم على العقيدة وتثمر المحبة والسكينة، كما أشار الله تعالى في قوله: ﴿وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ...﴾ [الأنفال: 63].

ومن صور المساندة أيضاً تقديم النصيحة للآخرين، كما في الحديث الشريف: "حق المسلم على المسلم خمس..." (متفق عليه) [رياض الصالحين، ب 144، ج 893:244].

والدعم المالي يُعد أيضاً من أهم أشكال التكافل، ويُفرض على الأغنياء لكفاية المحتاجين، كما جاء في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً...﴾ [التوبة: 103].

كما أن التعاون على البر والتقوى له دور كبير في ترسيخ العلاقات الإيجابية، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، ويؤيده حديث النبي ﷺ: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً" (متفق عليه) [رياض الصالحين، ب 27، ج 85:220].

ويشير رباعية (2009، ص. 15) إلى أن الإنسان اجتماعي بطبعه، ولا غنى له عن غيره في قضاء حوائجه. ويخلص الباحث إلى أن الإسلام يؤكد على أهمية المساندة الاجتماعية بكل أبعادها، كما تعد وسيلة فعالة لتعزيز التكيف، خاصة لمرضى الفشل الكلوي، لما توفره من دعم نفسي واجتماعي يساعدهم على التعايش مع مرضهم المزمن.

المساندة الاجتماعية ومرضى الفشل الكلوي المزمن:

يُعد الفشل الكلوي مرضاً مزمناً يؤثر على الصحة النفسية والجسدية للمريض، ويستدعي تقديم المساندة الاجتماعية لما يسببه من فقدان الشعور بالأمان. وأظهرت دراسة العقاد (2015) وجود علاقة إيجابية بين المساندة الاجتماعية وكل من الأمل والرضا عن الحياة لدى المصابين. كما أوضحت دراسة السعدي (2019) ارتباط الدعم الاجتماعي المدرك بتحسين نوعية الحياة لدى مرضى الفشل الكلوي. وبيّنت دراسة قارة (2009) وجود علاقة بين المساندة الاجتماعية وتقبل العلاج، وأكدت دراسة مقداد (2015) على أهمية دعم الأسرة في مساعدة المريض على التكيف مع المرض وتقبل الذات.

المبحث الثاني: صورة الجسم

مفهوم صورة الجسم:

تُعرّف صورة الجسم بأنها "تصور ذهني يُكوّنه الفرد عن جسمه من حيث المظهر الخارجي، والأعضاء الداخلية، وكفاءتها، ويصاحبه مشاعر واتجاهات إيجابية أو سلبية" (القاضي، 2009، ص. 45).

ويشير عبد الحميد وكفافي في (فايد، 2010، ص. 45) إلى أنها "تشمل إدراك الفرد لخصائصه الجسدية والوظيفية، وتشكل جزءاً من مفهوم الذات.

ووفقاً للشاعر (2014، ص. 94) فهي "موقف الفرد تجاه شكل جسمه وحجمه وجماله، وتشمل تقييماته الانفعالية".

ويضيف رشاد (2015، ص. 45) أن هذه الصورة قد تكون مصحوبة بمشاعر متباينة. ويُخلص الباحث إلى أن صورة الجسم تمثل تصورات ذهنية حول الشكل والتناسق والأداء، تتراوح بين الإيجابية والسلبية.

صورة الجسم من منظور إسلامي:

تُعد صورة الجسم سمة تميز الإنسان، وقد خُلق بها منذ أن كان في رحم أمه، كما جاء في قوله تعالى: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: 8]. وكل إنسان له صورة حسنة، فالله ﷻ خلق الإنسان في أحسن تقويم، حتى لو كانت هناك عاهات أو اختلافات ظاهرية ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ [غافر: 64].

وقد ميّز الله الإنسان عن باقي المخلوقات، وفضل بعضهم على بعض ﴿انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [الإسراء: 21]. وفي الإسلام، يُنظر إلى الجسم من ثلاثة أبعاد: *ديني* من خلال أداء الشعائر، *اجتماعي* من خلال التفاعل مع القيم والعلاقات، و*شخصي* يتعلق بالسلوكيات الخاصة كالعلاقة الزوجية. ويُقسّم الجسم أيضاً إلى ثنائية النفس والجسد، حيث تتحكم النفس بالجسد لا العكس (الزاهي، 1999، ص. 48). ويؤكد الباحث أن صورة الجسم تلعب دوراً محورياً في تشكيل مفهوم الذات وتحقيق التوازن النفسي.

صورة الجسم ومرضى الفشل الكلوي:

يُعتبر مفهوم صورة الجسم معقداً ويتطور عبر مراحل نمو الفرد، إذ تحدد صورة الجسم شخصية الفرد وتأثيرها على رضاه عن نفسه وتقبله لذاته، مما يؤثر إيجابياً أو سلبياً على حياته (القاضي، 2009، ص. 67). حيث يعاني مرضى الفشل الكلوي من تغيرات جسمية مثل تغير لون البشرة، تورم الأطراف، وأجهزة الغسيل التي تؤثر على صورة الجسم لديهم. ويحتاج هؤلاء المرضى إلى قبول صورة أجسامهم لتعزيز التفاؤل وتحسين التكيف مع المرض، حيث أكدت دراسة الأطرش (2015) العلاقة بين صورة الجسم والتوافق النفسي الاجتماعي. كما بينت دراسات فايد (2006)، يسينس وآخرون (Yucens 2019) أن المساندة الاجتماعية تعزز رضا المريض عن صورة جسمه وترفع الأمل لديه، مما يقلل الاضطرابات النفسية. ويخلص الباحث إلى أن المساندة الاجتماعية وصورة الجسم مرتبطتان بتجربة مرضى الفشل الكلوي، فكلما زادت المساندة الاجتماعية تحسنت صورة الجسم والعكس صحيح، مما يؤثر على الصحة النفسية وجودة الحياة.

الطريقة والإجراءات:

منهج الدراسة: تستند هذه الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي.

مجتمع الدراسة: يشمل مجتمع الدراسة جميع مرضى الفشل الكلوي المزمّن المترددين على قسم الغسيل الكلوي في مجمع ناصر الطبي ومستشفى أبو يوسف النجار، وعددهم (246) مريضاً، وفق إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية لعام 2023م.

عينة الدراسة:

استعمل الباحث طريقة الحصر الشامل بسبب صغر حجم المجتمع، ووزع 205 استبانة بطريقة العينة القصدية، تمثل 100% من المجتمع. بعد جمع البيانات، تم استرداد 83.3% من الاستبانات، ليصبح حجم العينة التي أُجري عليها التحليل 205 استبانة.

والجدول التالي يبين توزيع عينة الدراسة وخصائصها الديموغرافية تبعاً لمتغيراتها (النوع، المؤهل العلمي مدة الإصابة):

جدول (1): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة (ن=205)

المتغير	مستويات المتغير	العدد	النسبة المئوية (%)
النوع	ذكر	120	58.5
	أنثى	85	41.5
	المجموع	205	100%
المؤهل العلمي	لا يقرأ ولا يكتب	53	25.8
	ثانوية عامة فما دون	113	55.1
	جامعي	39	19.1
	المجموع	205	100%
مدة الإصابة	12-1 شهر	33	16.1
	1- 5 أعوام	98	47.8
	5 أعوام فأكثر	74	36.1
	المجموع	205	100%
العمر	أقل من 25 سنة	22	10.73
	25 سنة إلى أقل من 35 سنة	35	17.1
	35 سنة إلى أقل من 45 سنة	30	14.63
	45 سنة فأكثر	118	57.56
	المجموع	205	100%

يبيّن الجدول أن 58.5% من مرضى الفشل الكلوي في مجمع ناصر ومستشفى أبو يوسف النجار كانوا ذكوراً، و41.5% 356 إناثاً. من حيث المؤهل العلمي، 25.6% لا يقرأون ولا يكتبون، و55.3% يحملون شهادة ثانوية فأعلى، و18.1% جامعيون. بالنسبة لمدة الإصابة، 15.9% أقل من سنة، و47.9% بين 1-5 سنوات، و36.2% أكثر من 5 سنوات. أما العمر، ف10.73% أقل من 25 سنة، و17.1% بين 25 وأقل من 35، و14.63% بين 35 وأقل من 45، و57.56% فوق 45 سنة.

أدوات الدراسة:

بعد اطلاع الباحث على الأدب النظري وعدد من الدراسات السابقة والأدوات المستخدمة فيها، قام الباحث باستخدام مقياسين بالإضافة إلى استمارة البيانات الشخصية للعينة وهي:

جدول (2): أقسام أداة الدراسة الرئيسية

رقم القسم	عنوان القسم	عدد الفقرات
-	البيانات الشخصية	3
أولاً	مقياس المساندة الاجتماعية إعداد (زعر، 2018)	55
ثانياً	مقياس صورة الجسم إعداد (الشاعر، 2014)	34

يبين الجدول السابق أقسام أداة الدراسة، وعدد فقرات كل قسم منها.

مقياس المساندة الاجتماعية:

أ. إعداد الأداة:

لتنفيذ أهداف الدراسة، اطّلع الباحث على عدة مقاييس للمساندة الاجتماعية، واستفاد منها، واعتمد مقياس (زعر، 2018) لملاءمته لأهداف الدراسة والبيئة الفلسطينية، ويتكون هذا المقياس في صورته النهائية من 55 فقرة.

ب. وصف المقياس:

المقياس يهدف إلى قياس مستوى المساندة الاجتماعية لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن، ويتألف من 55 فقرة تغطي أربعة أبعاد رئيسية تشمل: المساندة العاطفية، مساندة الصحة الاجتماعية، المساندة الأدائية، ومساندة التوجيه وتقديم المعلومات. يتيح هذا المقياس فهم جوانب الدعم الاجتماعي التي يتلقاها المرضى وتأثيرها على حالتهم الصحية والنفسية.

ت. تصحيح المقياس:

المقياس يتراوح من 55 إلى 275 درجة، ويُقاس عبر خمس مستويات وفق طريقة ليكرت: (موافق بشدة=5، موافق=4، محايد=3، غير موافق=2، غير موافق بشدة=1). أعلى درجة ممكنة هي 275، وأدناها 55، والدرجة المتوسطة 123 تُستعمل لتقييم مستوى المساندة الاجتماعية. يوضّح الجدول القادم أبعاد المقياس وطريقة تصحيحه.

جدول (3): عدد فقرات المساندة الاجتماعية حسب كل مجال من مجالاتها

أبعاد المقياس	عدد الفقرات	طريقة التصحيح	
		الدرجة الدنيا	الدرجة العليا
بُعد المساندة العاطفية.	19	19	95
بُعد مساندة الصحة الاجتماعية.	14	14	70
بُعد المساندة الأدائية "الإجرائية".	13	13	65
بُعد مساندة التوجيه وتقديم المعلومات.	9	9	45
الدرجة الكلية للمساندة الاجتماعية	55	55	275

دلالات صدق وثبات مقياس المساندة الاجتماعية:

صدق المقياس يعني أنه يقيس ما صُمم من أجله. لم يقيم الباحث بحساب صدق المقياس بنفسه لأنه استخدم سابقاً في البيئة الفلسطينية، قد تحقق الباحث من صدق مقياس صورة الجسم من خلال الدراسة السابقة التي استخدمت هذه

المقياس، حيث أظهرت الدراسات السابقة صدقًا عاليًا في الاتساق الداخلي والصدق البنائي. كما تحقق الباحث من ثبات المقياس من خلال بيانات سابقة باستخدام معامل ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية، مما أكد أن المقياس يتمتع بدرجات عالية من الثبات. لذلك، يؤكد الباحث أن المقياس صالح وموثوق لاستعماله في الدراسة الحالية.

مقياس صورة الجسم:

أ. إعداد الأداة:

لغرض قياس مستوى صورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن، وبعد مراجعة الباحث للعديد من الدراسات السابقة والمقاييس العربية والأجنبية ذات الصلة، اعتمد مقياس (الشاعر، 2014) الذي يتكون من 34 فقرة، ويقاس أبعاد صورة الجسم بشكل شامل للمرضى في المستشفيات محل الدراسة.

ب. وصف المقياس:

المقياس يُستعمل لقياس صورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن، حيث يتناول خمسة أبعاد رئيسية تعكس الجوانب المختلفة لتصور الفرد عن جسمه، مما يساعد في تقييم مدى تأثر المرضى بصورة أجسامهم وتأثير ذلك على حالتهم النفسية والاجتماعية.

ت. تصحيح المقياس:

يتراوح مجموع درجات المقياس بين 34 و170، ويُقاس باستخدام مقياس ليكرت بخمس مستويات (موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة)، حيث تُعطى كل إجابة درجة من 1 إلى 5 حسب مستوى الموافقة. تُستخدم الدرجة المتوسطة 85 كنقطة مرجعية لتحديد مستوى صورة الجسم لدى العينة، بحيث تُعتبر الدرجات الأعلى من 85 دلالة على صورة جسم إيجابية، والأقل منها دلالة على صورة جسم أقل إيجابية.

دلالات صدق وثبات مقياس صورة الجسم:

يقصد بصدق المقياس قدرته على قياس ما صُمم لقياسه، ولم يقيم الباحث بحساب دلالات الصدق مباشرة لأن المقياس تم تطبيقه سابقًا في البيئة الفلسطينية. لكن تحقق الباحث من صدق المقياس عبر الدراسات السابقة التي استخدمته، والتي أظهرت صدقًا جيدًا في الاتساق الداخلي والصدق البنائي، مما يؤكد أن المقياس يقيس المفهوم المستهدف بدقة، ولذلك لم تُحذف أي فقرة منه. أما بالنسبة للثبات، فقد تم التحقق منه أيضًا في الدراسات السابقة باستخدام معامل ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية بمعامل جتمان، حيث ثبت أن المقياس يتمتع بدرجات عالية من الثبات، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في الدراسة الحالية. وهذا يضمن للباحث الاعتماد الكامل على صحة وثبات المقياس لتحليل النتائج والإجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

المحك المعتمد في الدراسة:

تم تحديد طول الخلايا في مقياس ليكرت الخماسي بحساب المدى بين درجات المقياس (5-1=4) وتقسيمه على أكبر قيمة (0.80=5/4)، ثم إضافة هذه القيمة إلى أقل درجة (1) لتحديد الحد الأعلى لكل خلية، وبذلك تم تحديد طول الخلايا.

الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة:

استخدم الباحث برنامج SPSS لمعالجة البيانات اعتماداً على عدة معالجات إحصائية، منها المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف العينة، ومعامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين المتغيرات ولحساب الاتساق الداخلي والصدق البنائي، بالإضافة إلى اختبار (ت) لعينة واحدة لفحص متوسط الاستجابة، واختبار (ت) لعينتين لمقارنة مجموعتين مستقلتين. كما تم استخدام الانحدار الخطي المتعدد، وتحليل التباين الأحادي (ANOVA) لاكتشاف الفروق بين ثلاث مجموعات أو أكثر، واختبار (LSD) للمقارنات البعدية بين مستويات المتغيرات التابعة.

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

النتائج المتعلقة بالتساؤل الأول:

التساؤل الأول: ما درجة المساندة الاجتماعية لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن؟

تمت الإجابة على السؤال باستخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لمستوى المساندة الاجتماعية، بالإضافة إلى اختبار (ت) لعينة واحدة، بهدف معرفة ما إذا كان متوسط الاستجابة قد بلغ درجة الموافقة المتوسطة (3) لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن في المستشفيات المعنية.

جدول (4): المتوسط الحسابي والنسبي والانحراف المعياري واختبار (ت) (t-test) لكل مجال من مجالات مقياس المساندة الاجتماعية

م	المجالات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	قيمة اختبار (ت)	القيمة الاحتمالية (Sig)	الترتيب	المستوى
1	المساندة العاطفية	4.164	0.394	83.29	46.30	.000	1	كبيرة
2	مساعدة الصحية الاجتماعية	3.635	0.341	72.71	29.24	.000	2	كبيرة
3	المساندة الأدائية	3.349	0.413	66.98	13.25	.000	4	متوسطة
4	مساعدة التوجيه وتقديم المعلومات	3.627	0.484	72.54	20.32	.000	3	كبيرة
	المتوسط الكلي	3.749	0.302	74.98	38.93	.000		كبيرة

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة $\alpha \leq 0.05$.

يتبين من الجدول (4) أن المتوسطات الحسابية لاستجابات عينة الدراسة حول مجالات مقياس المساندة الاجتماعية تراوحت بين (4.16 - 3.35)، إذ جاءت "المساندة العاطفية" في المرتبة الأولى بمتوسط (4.16) ووزن نسبي (83.29%)، بينما جاءت "المساندة الأدائية" في المرتبة الأخيرة بمتوسط (3.35) ووزن نسبي (66.98%)، مع بقاء مستوى الموافقة كبيراً في

جميع الأبعاد. وبلغ المتوسط العام للمقياس (3.75) ووزن نسبي (74.98%)، وقيمة اختبار (38.98) بدلالة إحصائية عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$). وتشير النتائج إلى أن مرضى الفشل الكلوي المزمن يتمتعون بدرجة عالية من المساندة الاجتماعية، خاصة العاطفية، ويظهرون اتجاهًا إيجابيًا نحوها، مما يعكس وعيهم بأهميتها.

يعزو الباحث ارتفاع مستوى المساندة الاجتماعية لدى مرضى الفشل الكلوي إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني، الذي يتميز بعاداته وتقاليدته المستندة إلى القيم الدينية الداعية للمحبة والتراحم، مثل زيارة المريض وتقديم الدعم. ويستشهد بحديث نبوي يبرز أهمية العناية بالمريض ضمن الواجبات الاجتماعية والدينية. ويرى أن المساندة الاجتماعية تمثل مصدراً مهماً للدعم النفسي والاجتماعي، إذ تساعد المرضى على التكيف مع المرض وتخفيف آثاره السلبية، وتعزز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على المواجهة، كما تدعم هذه النتيجة نتائج دراسات سابقة مثل دراسة "فاردانجاني وآخرون Vardanjani (2013)" و"مقداد (2015)"، والتي أظهرت أن المساندة الاجتماعية لمريض الفشل الكلوي كانت مرتفعة، بينما تختلف مع نتائج دراسة "شحاته (2015)" التي أشارت إلى انخفاض مستوى المساندة الاجتماعية لدى مرضى الأمراض المزمنة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

السؤال الثاني: ما درجة صورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن؟

تم الإجابة على هذا السؤال باستخدام المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والوزن النسبي لمستوى صورة الجسم، واختبار (ت) (t-test) لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة، وهي (3) أم لا لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن محل الدراسة، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (5): المتوسط الحسابي والنسبي والانحراف المعياري واختبار (ت) (t-test) لكل مجال من مجالات مقياس صورة الجسم

رقم	المجالات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	قيمة اختبار (ت)	القيمة الاحتمالية (Sig)	الترتيب	المستوى
1	التناسق العام لأجزاء الجسم	3.48	0.49	69.58	15.30	.000	2	كبيرة
2	المنظور النفسي لشكل الجسم	3.53	0.49	70.64	17.12	.000	1	كبيرة
3	المنظور الاجتماعي لشكل الجسم	3.36	0.36	67.21	15.82	.000	5	متوسطة
4	المحتوى الفكري لشكل الجسم	3.296	0.35	65.93	13.33	.000	4	متوسطة
5	المحتوى السلوكي لشكل الجسم	3.297	0.44	65.94	10.64	.000	3	متوسطة
	المتوسط الكلي	3.39	0.24	67.83	25.87	.000		متوسطة

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة $\alpha \leq 0.05$.

يتضح من الجدول (5) أن المتوسطات الحسابية لاستجابات عينة الدراسة حول مقياس صورة الجسم تراوحت بين (3.29 – 3.53)، حيث جاء "المنظور النفسي لشكل الجسم" في المرتبة الأولى بمتوسط (3.53) ووزن نسبي (70.64%)، بمستوى موافقة كبيرة، بينما جاء "المحتوى الفكري لشكل الجسم" في المرتبة الأخيرة بمتوسط (3.29) ووزن نسبي (65.93%) وبمستوى موافقة متوسطة. وبلغ المتوسط العام للمقياس (3.39) ووزن نسبي (67.83%)، مع دلالة إحصائية عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$). وتشير النتائج إلى أن صورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن تتوافر بدرجة متوسطة، مع وجود اتجاهات إيجابية نحوها، خاصة في الجانب النفسي، مما يدل على وعي أفراد العينة بأهمية هذا المفهوم.

يعزو الباحث النتيجة إلى أن أفراد العينة يعيشون في مجتمع إسلامي يفرض التمييز بين الأشخاص بناءً على الشكل أو اللون، مما يسهم في تحسين صورة الجسم لديهم. كما أن ثقافة المجتمع الداعمة والمحيطية بهذه الفئة لها أثر كبير في تعزيز هذا المفهوم. ويرى الباحث أن صورة الجسم تُعد متغيراً مهماً يؤثر في التوافق النفسي والاجتماعي، وهي من المحددات الأساسية لمفهوم الذات، إذ يؤثر تصور الفرد لجسده على مشاعره من سرور أو ألم، وقوة أو ضعف، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الشاعر (2014) التي أظهرت أن مستوى صورة الجسم بلغ 63%، بينما اختلفت مع دراسة بيسر وديمير (2020) التي بينت أن صورة الجسم لدى مرضى الغسيل الكلوي كانت متدنية.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

التساؤل الثالث: هل هناك علاقة بين المساندة الاجتماعية وصورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن؟

للإجابة عن هذا التساؤل تم اختبار الفرضية الاتية:

الفرضية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين المساندة الاجتماعية وصورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن.

ولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضيات عن طريق إيجاد معاملات الارتباط باستعمال "معامل بيرسون" بين الدرجة الكلية لمقياس المساندة الاجتماعية بأبعادها وصورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن لمعرفة ما إذا كان هناك علاقة بينهما، والجدول التالي يوضح نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون:

361

جدول (6): معاملات الارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة الدراسة للمقياس المساندة الاجتماعية بأبعاده وصورة الجسم لدى مرضى

الفشل الكلوي المزمن

متغير التابع صورة الجسم بأبعادها					متغير المساندة الاجتماعية بأبعادها		
الدرجة	المحتوى السلوكي	المحتوى الفكري	المنظور الاجتماعي	المنظور النفسي	التناسق العام لأجزاء الجسم	المؤشرات الإحصائية	المؤشرات الإحصائية
البعد	لشكل	لشكل	لشكل	لشكل	لشكل	لشكل	لشكل
الجسم	الجسم	الجسم	الجسم	الجسم	الجسم	الجسم	الجسم
المساندة العاطفية	معامل الارتباط	0.193**	-0.194	0.090	-0.023	0.181**	0.099
القيمة الاحتمالية	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.121

مساعدة الصحة الاجتماعية	معامل الارتباط	.187**	-.007	.200**	.128*	.250**	.267**
	القيمة الاحتمالية	.003	.918	.002	.045	.000	.000
المساندة الأدائية "الإجرائية"	معامل الارتباط	.243**	-.061	.304**	.135*	.067	.245**
	القيمة الاحتمالية	.000	.342	.000	.035	.295	.000
مساعدة التوجيه وتقديم المعلومات	معامل الارتباط	.268**	.010	.327**	.364**	.056	.365**
	القيمة الاحتمالية	.000	.871	.000	.000	.385	.000
الدرجة الكلية للمتغير	معامل الارتباط	.290**	-.106	.282**	.166**	.190**	.296**
المساندة الاجتماعية بأبعادها	القيمة الاحتمالية	.000	.099	.000	.009	.003	.000

*الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة $\alpha \leq 0.05$.

تشير نتائج الجدول (6) إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين المساندة الاجتماعية وصورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن، حيث كلما زادت المساندة الاجتماعية ارتفع مستوى صورة الجسم، وذلك بناءً على معامل ارتباط (0.296) وقيمة احتمالية (0.000) أقل من مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$)

يعزو الباحث قوة العلاقة بين المساندة الاجتماعية وصورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن إلى تجانس العينة ووعياً بأهمية المساندة الاجتماعية، حيث تسهم هذه المساندة في تخفيف الآلام والآثار النفسية والاجتماعية، وتساعد المرضى على التكيف مع المرض. ويرى أن تقبل الذات يعزز السلوك الصحي والثقة بالنفس، مما ينعكس إيجاباً على صورة الجسم. كما أشارت النتائج إلى توافقه مع دراسات سابقة أبرزها دراستا الأطرش (2015) والهنساوي (2014)، بينما خالفت دراسة مقداد (2015) التي لم تجد علاقة بين المساندة الاجتماعية وقلق المستقبل.

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى المساندة الاجتماعية تعزى لعامل (النوع، المؤهل العلمي، مدة الإصابة)؟

للإجابة على هذا التساؤل تم اختبار الفرضية الآتية:

الفرضية: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات استجابات المبحوثين حول المساندة الاجتماعية بأبعاده لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن تعزى للمتغيرات (النوع، المؤهل العلمي، مدة الإصابة).

وللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار (T-Test) في حالات العينتين المستقلتين (Independent Samples T-Test) واختبار الفروق التي تعزى لمتغير (النوع)، بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين لأحادي (One-Way ANOVA) لاختبار الفروق التي تعزى للمتغيرات (المؤهل العلمي، مدة الإصابة)، والتي تتكون من أكثر من مجموعتين، وفيما يلي اختبار الفرضية الرئيسية الخامسة وفقاً للبيانات الديموغرافية.

وينبثق عنها الفرضيات الفرعية الآتية:

الفرضية (1): توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات استجابات الباحثين حول المساندة الاجتماعية بأبعاده لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن تعزى لمتغير النوع.

ومن أجل تحديد الفروق تبعاً لمتغير النوع، تم استخدام اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين ونتائج الجدول التالي تبين ذلك:

جدول رقم (7): نتائج اختبار (ت) لدلالة الفروق بين متوسطات المساندة الاجتماعية بأبعاده تعزى لمتغير النوع

المتغير	النوع	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (ت) المحسوبة	قيمة "Sig."	مستوى الدلالة
المساندة الاجتماعية بأبعاده	ذكر	120	3.72	0.30	1.581-	0.115	غير دالة
	أنثى	85	3.79	0.31			

المصدر: الاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، 2023م.

أظهرت نتائج الجدول (7) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات آراء الباحثين حول المساندة الاجتماعية بأبعاده تعزى لمتغير النوع، حيث كانت القيمة الاحتمالية أكبر من مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$).

يعزو الباحث عدم وجود فروق في المساندة الاجتماعية بين الذكور والإناث من مرضى الفشل الكلوي إلى تشابه ظروفهم ومعاناتهم، وكونهم يتلقون نفس الدعم داخل بيئة اجتماعية إسلامية مترابطة لا تميز بين الجنسين، حيث يُقدم الدعم الأسري والمعنوي والمادي بالتساوي. كما أشار إلى أن ملاحظاته المباشرة دعمت هذا التفسير. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسات سابقة مثل رياش (2016) ومقداد (2015)، لكنها اختلفت مع دراسة المالكي (2019) التي وجدت فروقاً بين الجنسين في مستوى المساندة الاجتماعية.

الفرضية (2): توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات استجابات الباحثين حول المساندة الاجتماعية بأبعاده لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن تعزى لمتغير مدة الإصابة.

ومن أجل تحديد الفروق تبعاً لمتغير مدة الإصابة، تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) ونتائج الجدول التالي تبين ذلك:

جدول (8): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة حول مستوى المساندة الاجتماعية بأبعاده تعزى لمتغير مدة الإصابة

المتغير	مدة الإصابة	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
المساندة الاجتماعية بأبعاده	12-1 شهر	33	3.79	0.33
	5-1 أعوام	98	3.75	0.28
	5 أعوام فأكثر	74	3.73	0.31

المصدر: الاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، 2023م.

يتضح من الجدول (8) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة حول المساندة الاجتماعية بأبعاده، ومن أجل معرفة إن كانت هذه الفروق وصلت لمستوى الدلالة تم استعمال تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) والجدول التالي يبين ذلك:

جدول (9): نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في مستوى المساندة الاجتماعية بأبعاده تعزى لمتغير مدة الإصابة							
مقياس	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	قيمة "Sig."	مستوى الدلالة
المساندة الاجتماعية بأبعاده	بين المجموعات	0.08	2	0.040	0.442	0.643	غير دالة
	داخل المجموعات	22.24	243	0.092			
	المجموع	22.32	245				

المصدر: الاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، 2023م.

أظهرت نتائج الجدول (9) باستخدام اختبار التباين الأحادي عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات آراء الباحثين حول المساندة الاجتماعية بأبعاده تعزى لمتغير مدة الإصابة، حيث كانت القيمة الاحتمالية أكبر من مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$).

يعزو الباحث عدم وجود فروق في المساندة الاجتماعية حسب مدة الإصابة إلى أن معاناة مريض الفشل الكلوي تبدأ منذ لحظة تشخيصه، مما يستدعي تلقي الدعم الاجتماعي فوراً بغض النظر عن مدة المرض. كما يشير إلى أن طبيعة المجتمع الفلسطيني تُعزز تقديم الدعم لجميع المرضى دون تمييز، مما يجعل المساندة الاجتماعية متساوية تقريباً بينهم. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراستي مقداد (2015) والعقاد (2015)، اللتين أكدتا عدم وجود فروق دالة إحصائية تعزى لمدة الإصابة، لكنها اختلفت مع دراسة شحاته (2015) التي وجدت علاقة عكسية بين المساندة الاجتماعية وشدة أزمة المريض.

الفرضية (3): توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات استجابات الباحثين حول المساندة الاجتماعية بأبعاده لدى مرضى الفشل الكلوي المزمّن تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

ومن أجل تحديد الفروق تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) ونتائج الجدول التالي يبين ذلك:

جدول (10): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة حول مستوى المساندة الاجتماعية بأبعاده تعزى لمتغير المؤهل العلمي				
المتغير	المؤهل العلمي	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
المساندة الاجتماعية بأبعاده	لا يقرأ ولا يكتب	53	3.64	0.32
	ثانوية عامة فما دون	113	3.77	0.29
	جامعي	39	3.83	0.28

المصدر: الاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، 2023م.

يتضح من الجدول (10) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة حول المساندة الاجتماعية بأبعاده، ومن أجل معرفة إن كانت هذه الفروق وصلت لمستوى الدلالة تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) والجدول التالي يبين ذلك:

جدول (11): نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في مستوى المساندة الاجتماعية بأبعاده تعزى لمتغير المؤهل العلمي

مقياس	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف" المحسوبة	قيمة "Sig."	مستوى الدلالة
المساندة الاجتماعية بأبعاده	بين المجموعات	1.197	2	.598			
	داخل المجموعات	21.126	243	.087	6.884	.001	دالة
	المجموع	22.323	245				

المصدر: الاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، 2023م.

وقد تبين من الجدول (11) أنه باستخدام اختبار "التباين الأحادي" لمقارنة ثلاث متوسطات أو أكثر من البيانات، تبين أن القيمة الاحتمالية (Sig.) لإجابات المبحوثين كانت أقل من مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) وهذا يدل على وجود فروق ذات دلالة معنوية واضحة في متوسطات آراء المبحوثين تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

ولإيجاد الفروقات بين المجموعات حول المساندة الاجتماعية التي تعزى لمتغير المؤهل العلمي تم استخدام اختبار (LSD) كما مبين في الجدول التالي:

جدول (12): الفروقات بين المجموعات في المساندة الاجتماعية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

مقياس	المؤهل العلمي	لا يقرأ ولا يكتب	ثانوية عامة فما دون	جامعي
المساندة الاجتماعية	لا يقرأ ولا يكتب	1	-.13742*	-.19439*
	ثانوية عامة فما دون	.13742*	1	-.05697
	جامعي	.19439*	.05697	1

يتضح من الجدول (12) الآتي:

365 أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى المساندة الاجتماعية لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وكانت الفروق لصالح فئة "الجامعي" مقارنة بفئة "لا يقرأ ولا يكتب"، مما يشير إلى أن المرضى ذوي التحصيل العلمي الأعلى يتلقون مساندة اجتماعية أكبر.

يرى الباحث أن الفروق في مستوى المساندة الاجتماعية حسب المؤهل العلمي منطقية، إذ إن فئة "الجامعي" تتميز بوعي وثقافة أعلى، وقدرة أفضل على التكيف مع المرض مقارنة بغير المتعلمين، مما ينعكس على تلقيهم للمساندة الاجتماعية. كما أشار إلى أن كل فئة تتفاعل مع الدعم الاجتماعي بطريقة تختلف عن الأخرى تبعاً لمستوى نضجها وتعليمها. ويؤكد الباحث أن حاجة مريض الفشل الكلوي للدعم مستمرة بغض النظر عن مؤهله، نظراً لصعوبة التغيرات التي يمر بها. كما أشار إلى أن هذه النتيجة لم تتفق مع أي دراسة سابقة تناولت متغير المؤهل العلمي، ما يميز هذه الدراسة بتناولها لمتغيرات ديموغرافية شاملة تتناسب مع طبيعة مجتمع الدراسة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى صورة الجسم تعزى للمتغيرات (النوع، المؤهل العلمي، مدة الإصابة)؟

للإجابة على هذا التساؤل تم اختبار الفرضية الآتية:

الفرضية: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى صورة الجسم بأبعاده لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن تعزى للمتغيرات (النوع، المؤهل العلمي، مدة الإصابة).

وللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار (ت) T-Test في حالات العينتين المستقلتين (Independent Samples T-Test) واختبار الفروق التي تعزى لمتغير (النوع، ومدة الإصابة)، بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين لأحادي (One-Way ANOVA) لاختبار الفروق التي تعزى للمتغيرات (المؤهل العلمي)، والتي تتكون من أكثر من مجموعتين، وفيما يلي اختبار الفرضية الرئيسية السادسة وفقاً للبيانات الديموغرافية.

وينبثق عنها الفرضيات الفرعية الآتية:

الفرضية (1): توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى صورة الجسم بأبعاده لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن تعزى لمتغير النوع.

ومن أجل تحديد الفروق تبعاً لمتغير النوع، تم استعمال اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين ونتائج الجدول التالي تبين ذلك:

جدول (13): نتائج اختبار (ت) لدلالة الفروق بين متوسطات صورة الجسم بأبعاده تعزى لمتغير النوع

المتغير	النوع	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (ت) المحسوبة	قيمة "Sig."	مستوى الدلالة
مستوى صورة الجسم بأبعاده	ذكر	120	3.41	0.21	1.823	0.070	غير دالة
	أنثى	85	3.36	0.27			

المصدر: الاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، 2023م.

366

أظهرت نتائج الجدول (13) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات آراء المبحوثين حول صورة الجسم بأبعاده تعزى لمتغير النوع، حيث كانت القيمة الاحتمالية أكبر من مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$)، مما يشير إلى أن الذكور والإناث من مرضى الفشل الكلوي المزمن يتشابهون في إدراكهم لصورة أجسامهم.

يرى الباحث أن عدم وجود فروق في صورة الجسم بين الجنسين يعود إلى تعرض كلاهما لنفس التأثيرات النفسية والاجتماعية، إذ يسعى الذكور والإناث على حد سواء لعرض صورة إيجابية تعكس توازنهم النفسي والاجتماعي رغم معاناتهم من المرض نفسه. كما أشار إلى أن كلا الجنسين يدركان تأثير صورة الجسم على صحتهم النفسية وعلاقاتهم الاجتماعية. وتوافقت هذه النتيجة مع دراسات الشاعر (2014) وبخيت (2020)، لكنها اختلفت مع دراسة الرشيد (2019) التي وجدت فروقاً لصالح الإناث لدى مرضى السكري.

الفرضية (2): توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات استجابات المبحوثين حول صورة الجسم بأبعاده لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن تعزى لمتغير مدة الإصابة.

ومن أجل تحديد الفروق تبعاً لمتغير مدة الإصابة، تم استعمال تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) ونتائج الجدول التالي تبين ذلك:

جدول (14): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة حول مستوى صورة الجسم بأبعاده تعزى لمتغير مدة الإصابة

المتغير	مدة الإصابة	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
صورة الجسم بأبعاده	1-12 شهر	33	3.37	0.26
	1-5 أعوام	98	3.41	0.21
	5 أعوام فأكثر	74	3.37	0.26

المصدر: الاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، 2023م.

يتضح من الجدول (14) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة حول صورة الجسم بأبعاده، ومن أجل معرفة إن كانت هذه الفروق وصلت لمستوى الدلالة تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) والجدول التالي يبين ذلك.

جدول (15): نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في مستوى صورة الجسم بأبعاده تعزى لمتغير مدة الإصابة

مقياس	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف" المحسوبة	قيمة "Sig."	مستوى الدلالة
صورة الجسم بأبعاده	بين المجموعات	0.12	2	.062	1.096	.336	غير دالة
	داخل المجموعات	13.68	243	.056			
	المجموع	13.81	245				

المصدر: الاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، 2023م.

أظهرت نتائج الجدول (15) باستعمال اختبار التباين الأحادي أن القيمة الاحتمالية أكبر من مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$)، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات آراء المبحوثين حول صورة الجسم بأبعاده تعزى لمتغير مدة الإصابة لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن.

يرى الباحث أن عدم وجود فروق في صورة الجسم حسب مدة الإصابة يعود لطبيعة مرض الفشل الكلوي المزمن ومضاعفاته، إذ يعاني المريض منذ بداية المرض من تغيرات جسمية ونفسية تؤثر على تصور نفسه وعلاقاته الاجتماعية، ما يجعل تأثير المرض على صورة الجسم ثابتاً بغض النظر عن مدة الإصابة. وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسات مثل (Demet، 2012) و(بيسر وديمير، 2020) التي وجدت تدهوراً في صورة الجسم مع طول فترة الإصابة والغسيل الكلوي.

الفرضية (3): توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات استجابات المبحوثين حول صورة الجسم بأبعاده لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

ومن أجل تحديد الفروق تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) ونتائج الجدول التالي تبين ذلك:

جدول (16): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة حول مستوى صورة الجسم بأبعاده تعزى لمتغير المؤهل العلمي

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	المؤهل العلمي	المتغير
0.21	3.39	53	لا يقرأ ولا يكتب	صورة الجسم بأبعاده
0.23	3.38	113	ثانوية عامة فما دون	
0.29	3.42	39	جامعي	

المصدر: الاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، 2023م.

يتضح من الجدول (16) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة حول صورة الجسم بأبعاده، ومن أجل معرفة إن كانت هذه الفروق وصلت لمستوى الدلالة تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) والجدول التالي يبين ذلك:

جدول (17): نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في مستوى صورة الجسم بأبعاده تعزى لمتغير المؤهل العلمي

مقياس	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف" المحسوبة	قيمة الدلالة	مستوى الدلالة
صورة الجسم بأبعاده	بين المجموعات	0.06	2	.032	.567	.568	غير دالة
	داخل المجموعات	13.74	243	.057			
	المجموع	13.81	245				

المصدر: الاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، 2023م.

أظهرت نتائج الجدول (17) باستعمال اختبار التباين الأحادي أن القيمة الاحتمالية كانت أكبر من مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$)، مما يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات آراء المبحوثين حول صورة الجسم بأبعاده تعزى لمتغير المؤهل العلمي لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن.

يعزو الباحث عدم وجود فروق في صورة الجسم بين فئات المؤهل العلمي إلى تشابه تجربة المرض والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها المرضى، حيث يتلقون دعمًا ومعلومات متساوية حول مرض الفشل الكلوي المزمن بغض النظر عن مستواهم التعليمي. ويرى أن المجتمع الإسلامي الذي ينتمي إليه المرضى لا يميز بين الأفراد إلا بالتقوى، مما يجعل المرض والتحديات المرتبطة به متشابهة لدى الجميع، وبالتالي فإن التفرقة بينهم تكون محدودة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتيجة تختلف مع دراسة إسماعيل (2017) التي وجدت فروقًا دالة إحصائية في رضا المرضى عن صورة الجسم بناءً على المؤهل العلمي.

نتائج الدراسة:

النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

- 1- أظهرت النتائج توافر أبعاد المساندة الاجتماعية بشكل عام بدرجة موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المتغير وهي متوافر بنسبة (74.98%).
- 2- كشفت نتائج الدراسة عن توافر أبعاد صورة الجسم بشكل عام بدرجة موافقة متوسطة من قبل أفراد عينة الدراسة وهي متوفرة بنسبة (67.83%).
- 3- بينت النتائج أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين المساندة الاجتماعية وصورة الجسم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن.
- 4- أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات استجابات المبحوثين حول المساندة الاجتماعية بأبعاده لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن تعزى للمتغيرات النوع، مدة الإصابة، وتبين وجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
- 5- أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى صورة الجسم بأبعاده لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن تعزى للمتغيرات النوع، المؤهل العلمي، مدة الإصابة.

المقترحات:

تقترح الدراسة إجراء أبحاث مستقبلية نوعية لفهم أعمق لتجربة المرضى النفسية، إضافة إلى دراسات مقارنة بين مرضى الفشل الكلوي ومرضى أمراض مزمنة أخرى. كما يُقترح تحليل أثر أنواع الدعم المختلفة (العاطفي، المعلوماتي، المادي) على صورة الجسم، إلى جانب تنفيذ دراسات طولية لرصد التغيرات بمرور الوقت، واستكشاف دور الوسائط الرقمية في تقديم الدعم الاجتماعي.

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة، توصي بضرورة تعزيز برامج الدعم الاجتماعي داخل مراكز غسيل الكلى من خلال إشراك الأسرة والمجتمع المحلي، وتدريب الكوادر الطبية على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الفعال. كما تُوصى بتطوير برامج إرشادية لتحسين صورة الجسم لدى المرضى، مع مراعاة الفروق التعليمية عند تصميم هذه البرامج لضمان فعاليتها لجميع الفئات.

المراجع

- إبراهيم، ماجدة. (2017). المساندة الاجتماعية وعلاقتها بالألم لدى عينة من مرضى السرطان. *دراسات تربوية واجتماعية*، 23 (1).
- إسماعيل، أهل. (2017). سمات الشخصية وعلاقتها بصورة الجسم لدى عينة من البدناء [رسالة ماجستير غير منشورة]. الجامعة الإسلامية، غزة.
- بخيت، حسين. (2020). صورة الجسم كمنبئ لنوعية الحياة والقلق لدى مريضات سرطان الثدي. *المجلة المصرية للدراسات النفسية*، 10 (30).
- الهندساوي، أحمد. (2014). المساندة الاجتماعية المدركة وإضطراب صورة الجسم والشعور بالذنب كمؤشرات للتنبؤ باستراتيجيات مواجهة الضغوط لدى عينة من طلاب الجامعة، *المجلة العلمية لكلية الآداب*، 49.
- الدامر، نوار. (2014). الصلابة النفسية وعلاقتها بالمساندة الاجتماعية لدى المصابات بسرطان الثدي في مدينة الرياض [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة الأمير نايف، الرياض.
- رباعية، عبد الله. (2009). النقاط: دراسة فقهية اجتماعية. *الأردنية في الدراسات الإسلامية*، 5 (3).
- الربيعية، فهد. (1997). الوحدة النفسية والمساندة الاجتماعية لدى عينة من طلاب وطالبات الجامعة: دراسة ميدانية. *مجلة علم النفس*، ع 43، القاهرة.
- رشاد، علي. (2015). *أساسيات الصحة النفسية والعلاج النفسي*. مؤسسة المختار.
- رشوان، بهجت. (2009). *فعالية استخدام خدمة الفرد الجماعية لتحقيق المساندة الاجتماعية لمريض الفشل الكلوي*. ورقة مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني والعشرين للخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، كلية الخدمة الاجتماعية.

الرشيد، لأولؤة. (2019). اضطراب صورة الجسم وعلاقته بالشعور بالاكئاب لدى عينة من مرضى السكري. *المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية*، 6 (2).

الزاهي، فريد. (1999). *الجسد المقدس في الاسلام*، (د.ط.). الشرق بيروت.

زعر، عثمان. (2018). *المساندة الاجتماعية وقلق المستقبل وعلاقتها بالتوجه نحو الحياة لدى زوجات الشهداء بمحافظة غزة* (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة القدس المفتوحة، غزة.

السعدي، رحاب. (2019). *الدعم الاجتماعي المدرك وعلاقته بنوعية الحياة لدى مرضى الفشل الكلوي في فلسطين* (دراسة تطبيقية في محافظة جنين). *مجلة جامعة القدس للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية*، 11 (31).

الشاعر، مسرة. (2014). *صورة الجسم والاكئاب وعلاقتها ببعض المتغيرات لدى جرحى الحروق في قطاع غزة* [رسالة ماجستير غير منشورة]. الجامعة الإسلامية، غزة.

الشبراوي، أنور. (2001). *علاقة صورة الجسم ببعض متغيرات الشخصية لدى المراهقين، مجلة كلية التربية*، 13 (38).

شحاته، فوزي. (2015). *المساندة الاجتماعية في حالة أزمة الإصابة بالمرض المزمن* [رسالة ماجستير غير منشورة]. كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة الفيوم، مصر.

الشرفين، أحمد. والوهبي، إيناس. (2018). *القدرة التنبؤية لصورة الجسد والاتزان الانفعالي بإدمان السيليبي لدى* 371 *طلبة الجامعات الأردنية. مجلة جامعة الخليل للبحوث*، 13 (1).

العقاد، ساري. (2015). *المساندة الاجتماعية وعلاقتها بالأمل والرضا عن الحياة لدى مرضى الفشل الكلوي في* *محافظات غزة* [رسالة ماجستير غير منشورة]. كلية التربية، جامعة الأقصى، غزة.

علي، إيهاب. (2020). *المساندة الاجتماعية وعلاقتها بمعني الحياة لدى المرضى بأمراض مزمنة* [رسالة دكتوراه]. *مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية*، 3 (50).

فايد، جمال. (2006). صورة الجسم وعلاقتها ببعض أنماط التفاعلات الاجتماعية لدى التلاميذ في مرحلة الطفولة المتأخرة. *مجلة كلية التربية، 1* (60).

فايد، حسني. (2010). *سلسلة في علم النفس دراسات في السلوك والشخصية*. مؤسسة طبية للنشر والتوزيع.

القاضي، وفاء. (2009). قلق المستقبل وعلاقته بصورة الجسم ومفهوم الذات لدى البتر بعد الحرب على غزة [رسالة ماجستير غير منشورة]. الجامعة الإسلامية، غزة.

مقداد، غالب. (2015). *قلق المستقبل لدى مرضى الفشل الكلوي وعلاقته ببعض المتغيرات* [رسالة ماجستير غير منشورة]. الجامعة الإسلامية، غزة.

موسى، محمد. والبغدادي، مي. (2017). اضطراب تشوه صورة الجسم وعلاقتها بقلق المستقبل لدى عينة من مرضى السكري. *مجلة التربية الخاصة والتأهيل، 4* (14).

النووي، محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف (ب.ت). *رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين*، مكتبة الإيمان، المنصورة، جامعة القاهرة.

Abboud, H. & Henrich, WL. (2010). Clinical practice. Stage IV chronic kidney disease. *N Engl J Med.* ,362(1).

372 Biçer, S. & Demir, G. (2020). Determination of body image perception and life satisfaction in patients undergoing hemodialysis. *Journal of Novel Physiotherapy and Rehabilitation, 4*.

Hettiarachchi, R. and Abeysena, Ch. (2018). Association of Poor Social Support and Financial Insecurity with Psychological Distress of Chronic Kidney Disease Patients. *International Journal of Nephrology*.

- Kimmel, P. and Peterson, R. (2005). Depression in End-Stage Renal Disease Patients Treated with Hemodialysis: Tools, Correlates, Outcomes and Needs. *Seminars in Dialysis*, 18(2).
- Smeltzer, S. & Bare, B.(2000). *Burnner & Suddarths Text Book of Medical Surgical Nursing*,9th ed.
- Vardanjani, S., Khalili, F., Dehkordi, F., Vardanjani, M., & Vardanjani, A. (2013). Perceived Social Support and Depression Factors in Hemodialysis Patients. *World Appl Sci J*, 25(3).
- Yucens, B., et al. (2019) .The association between hope, anxiety, depression, coping strategies and perceived social support in patients with chronic kidney disease. *Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences* ,32, 1.
- Zengin, O. et al. (2018). Anxiety, Coping and Social Support Among Parents Who Have Children with Chronic Kidney Disease. *Konuralp Medical Journal*, 10.